VỆ SINH BỆNH ViỆN

MỤC TIÊU

1. Trình bày được vai trò của vệ sinh bệnh viện
2. Phân tích được khái niệm, các nguồn lây nhiễm, đường truyền bệnh và các tác nhân gây nhiễm trùng bệnh viện chính.
3. Phân tích được một số NTBV phổ biến hiện nay và các biện pháp dự phòng NTBV
4. Trình bày được các giải pháp dự phòng NKBV

Tài liệu tham khảo

- Bài vệ sinh và qui hoạch bệnh viện
- Bộ môn SKMT (2012), Sức khỏe Môi trường
- Bộ Y tế, BV Bạch Mai, Qui định kiểm soát nhiễm khuẩn- Nhà xuất bản Y học 2000
- TS. Nguyễn Việt Hùng- Vệ sinh tay trong phòng ngừa NKBV, Nhà xuất bản Y học 2010
- Thông tư số 18/2009/TT-BYT về hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (ngày 14/10/2009)

Tài liệu tham khảo

- WHO, Practical Guidelines for Infection Control in Health Care Facilities, 2004
- WHO, Prevention of Hospital acquired infection, 2nd edition, 2002

A.Tại sao phải vệ sinh bệnh viện?

1. Quan trọng trong xây dựng hệ thống y tế quốc gia đảm bảo việc KCB cho nhân dân
2. Tạo ra một môi trường thuận lợi cho việc điều trị bệnh tật và phục hồi sức khỏe
3. Hạn chế các tai biến điều trị, hạn chế nguy cơ lây lan bệnh chéo ở BV và giữa BV với khu dân cư
4. Giáo dục sức khỏe
5. Đảm bảo an toàn lao động nghề nghiệp cho NVYT

B. Một số yêu cầu vệ sinh bệnh viện

B1. Khu đất xây dựng bệnh viện:

B.1.1. Địa điểm:

- Khu trung tâm dân cư
- Các BV lao, tâm thần, phong...ở xa khu dân cư ≥ 1000 m.
- Khu yên tĩnh, cao ráo
- Không nên chọn địa điểm BV ở những nơi phát sinh tiếng ồn, rác thải

B. Một số yêu cầu vệ sinh bệnh viện

B1. Khu đất xây dựng bệnh viện:

B.1.2. Diện tích khu đất bệnh viện

- Phụ thuộc vào: qui mô BV, mức độ TTB, điều kiện đất cho phép.
- Thường lấy mức 100-150 m2/1 GB để tính ra tổng diện tích khu đất cần thiết cho một BV

B. Một số yêu cầu vệ sinh bệnh viện

B1. Khu đất xây dựng bệnh viện:

B.1.3. Bố trí mặt bằng xây dựng trong bệnh viện

- Cây xanh và vườn hoa: 50-60% diện tích mặt bằng
- Các công trình kiến trúc trong bệnh viện được chia thành
  - Khu hành chính, phòng khám
  - Khu điều trị bệnh nhân
  - Khu vực hậu cần, quản trị
- 80% tổng diện tích xây dựng BV: cho 3 khu trên
- 20% tổng diện tích xây dựng còn lại: các việc khác

B. Một số yêu cầu vệ sinh bệnh viện

B1. Khu đất xây dựng bệnh viện:

B.1.4. Yêu cầu vệ sinh giữa các khu

- Khoảng cách giữa giữa các khu phải xa ít nhất 20 mét
- K.cách từ khoa lây tới các khoa khác xa ít nhất 30 mét
- K.cách từ các buồng bệnh đến nhà dân xa ít nhất 30 m

B2. Thiết kế các phòng trong BV

B2.1. Kích thước các phòng và lối đi lại giữa các phòng:

- **Chiều rộng lối đi lại thường là 2,2 mét.**
- **Chiều sâu phòng tối đa không quá 6 mét**
- **Chiều cao trần nhà của các phòng tốt nhất là 3,5 mét**

B2.2. Hệ thống ánh sáng các phòng

- Phòng mổ, phòng thay băng, phòng sản 1/1
- Phòng bác sĩ, phòng điều trị, phòng chẩn đoán 1/5
- Phòng xét nghiệm, phòng dược 1/6
- Phòng bệnh nhân 1/7

Cách sắp xếp giường bệnh trong các phòng

– Mức diện tích sàn nhà TB/mỗi giường bệnh từ 6-9 m2.
– Mỗi phòng bệnh nên có 1-6 giường bệnh
– Các giường bệnh cần kê cách xa nhau 0.9-1 mét
– Mỗi khu điều trị BN cần có ít nhất một phòng riêng biệt dành cho BN rất nặng hoặc nghi mắc bệnh lây.

B2.3. Số lượng các phòng trong bệnh viện

a) Nhóm nhà điều trị

b) Nhóm nhà vệ sinh

c) Nhóm nhà phục vụ sinh hoạt

- Mỗi bệnh viện có 25-30 giường bệnh cần bố trí ít nhất 10 buồng bệnh nhân, 20 phòng phục vụ điều trị.

B2.4. Buồng bệnh nhân

- **Hệ thống chiếu sáng theo 3 cách:**
  - Chiếu sáng cả hai bên.
  - Chiếu sáng một bên, một bên là các buồng phục vụ.
  - Chiếu sáng một bên, một bên là hành lang
- **Hành lang rộng 2,20m (nếu ở bên ngoài) và rộng từ 2,30 - 2,50m (nếu ở bên trong).**

3. Nhiễm trùng bệnh viện:

3.1. Khái niệm

- Là nhiễm trùng mắc phải khi bệnh nhân nằm viện mà lý do nhập viện không phải do nhiễm trùng đó, xuất hiện 48 giờ sau nhập viện và 30 ngày đối với nhiễm trùng vết mổ
- Chỉ tiêu đánh giá chất lượng BV, đảm bảo an toàn cho người bệnh và nhân viên y tế
- Nhiễm khuẩn liên quan tới chăm sóc y tế (health care-associated infection)

Hậu quả của nhiễm trùng bệnh viện

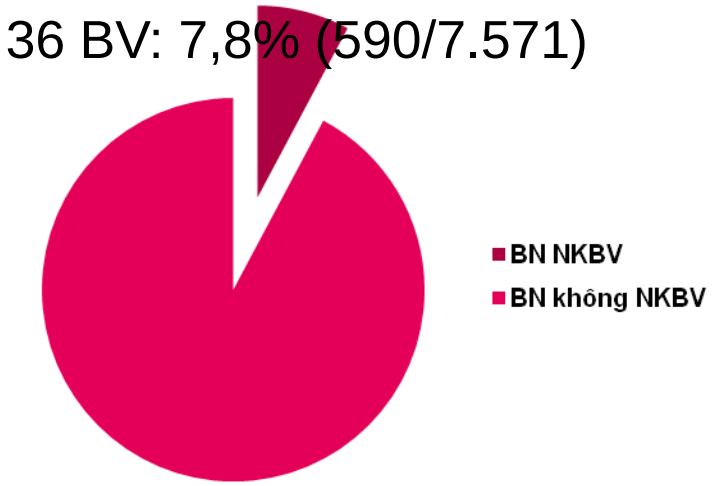
- Tăng tỷ lệ mắc bệnh
- Tăng tỷ lệ tử vong
- Kéo dài ngày nằm điều trị
- Tăng chi phí điều trị
- Gia tăng chủng VK kháng thuốc: TC vàng kháng Methicilin, Cầu khuẩn đường ruột kháng Vancomycin…

Chỉ số đánh giá nhiễm trùng bệnh viện

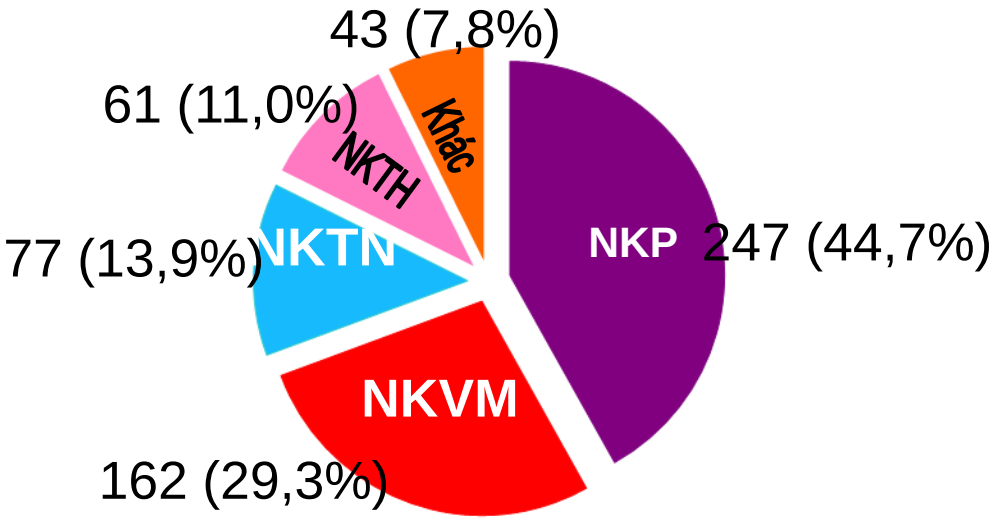
- Tỷ lệ mắc nhiễm trùng bệnh viện
- Mật độ nhiễm trùng bệnh viện

THỰC TRẠNG NKBV Ở VIỆT NAM

- **Từ 5,7% tới 11,0% BN mắc NKBV**
- **Ước tính 500.000 NKBV/năm**
- **Thời gian và chi phí điều trị tăng gấp 2 lần**

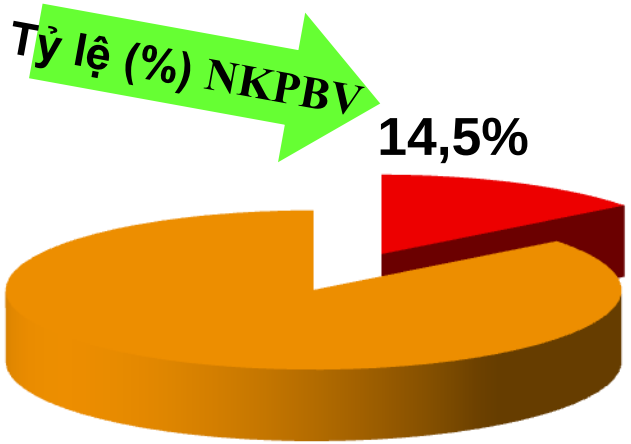


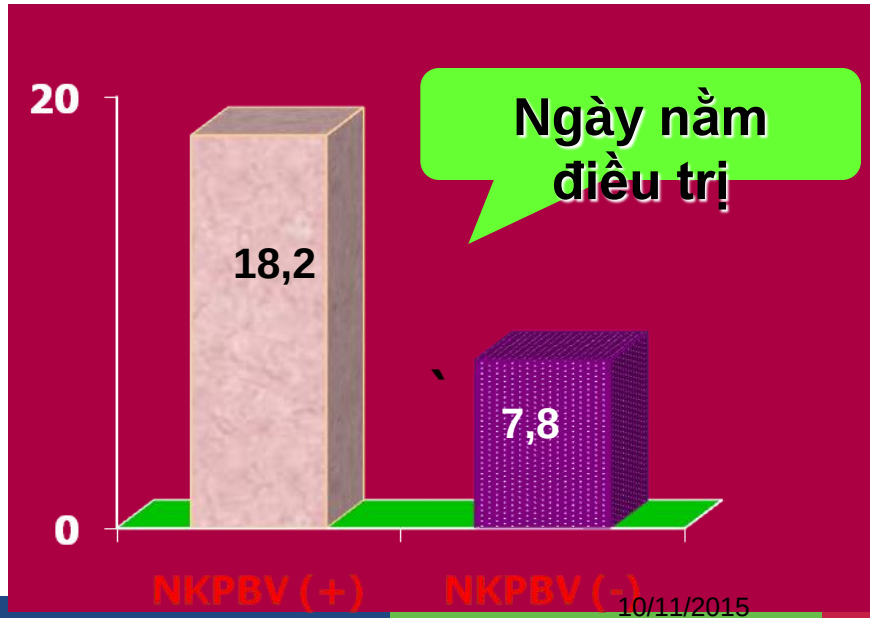
Tỷ lệ NKBV Ở 36 bv (2007)

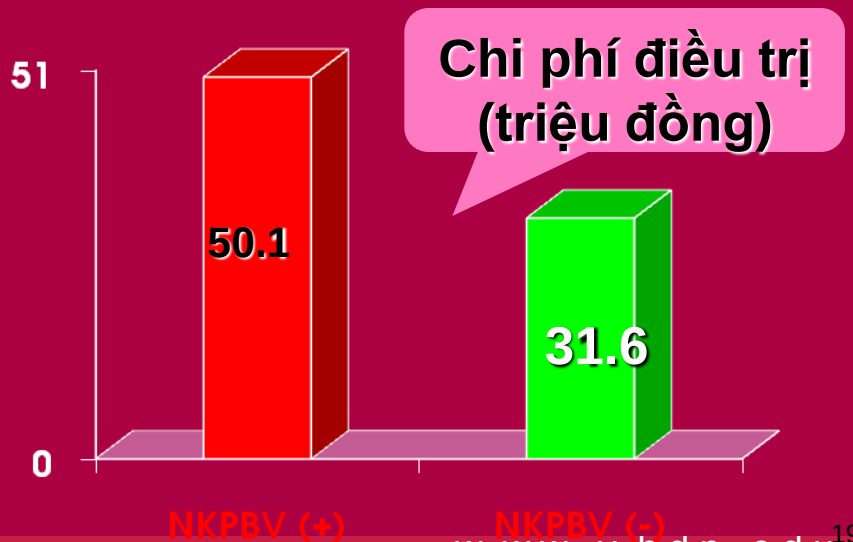


Phân bố NKBV Ở 36 bv (2007)

NKP BV tại khoa HSTC – BVBM







3.2. Nguồn lây nhiễm.

- Con người: BN, NVYT, người nhà, khách thăm
- Vật liệu dụng cụ y tế
- Môi trường: không khí, đất, bề mặt, nước.

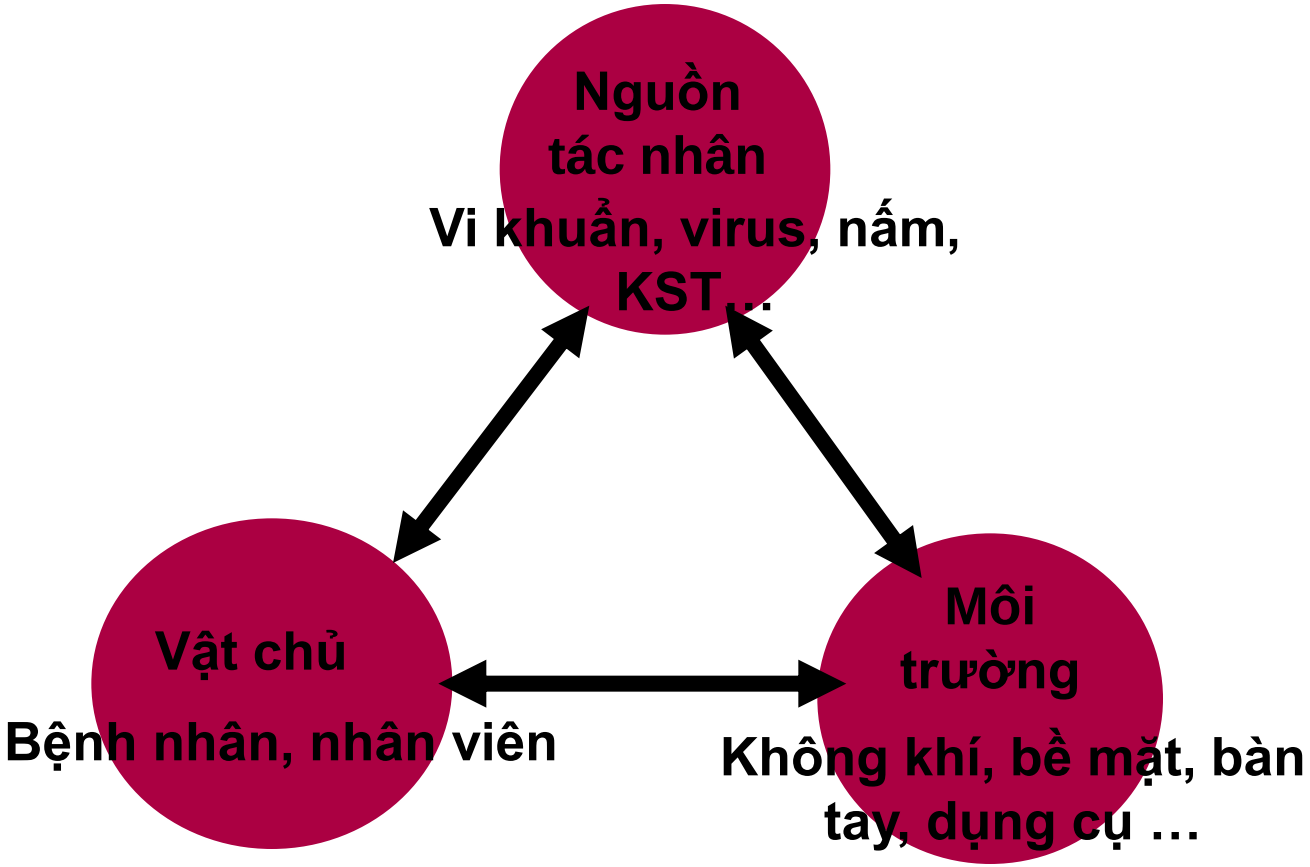
3.3. Nguyên nhân gây nhiễm trùng bệnh viện:

- Do sử dụng nhiều KS không đúng nguyên tắc
- Do tăng số lượng người ra vào bệnh viện
- Do tăng sự di chuyển của các bệnh nhân
- Sử dụng những KT chẩn đoán và điều trị tăng
- Do chưa có chính sách, đầu tư thỏa đáng
- Do nhân viên y tế ít được đào tạo nghiệp vụ
- Do chưa tuân thủ chặt chẽ những qui định VSBV

3.4. Phương thức lây truyền

- **Qua tiếp xúc trực tiếp (đường bàn tay). Chủ yếu qua bàn tay hoặc dụng cụ y tế (90% tất cả các loại NKBV)**
- **Qua các giọt bắn (>5µm): 9% NKBV**
- **Qua không khí (<5 µm): 1% NKBV**

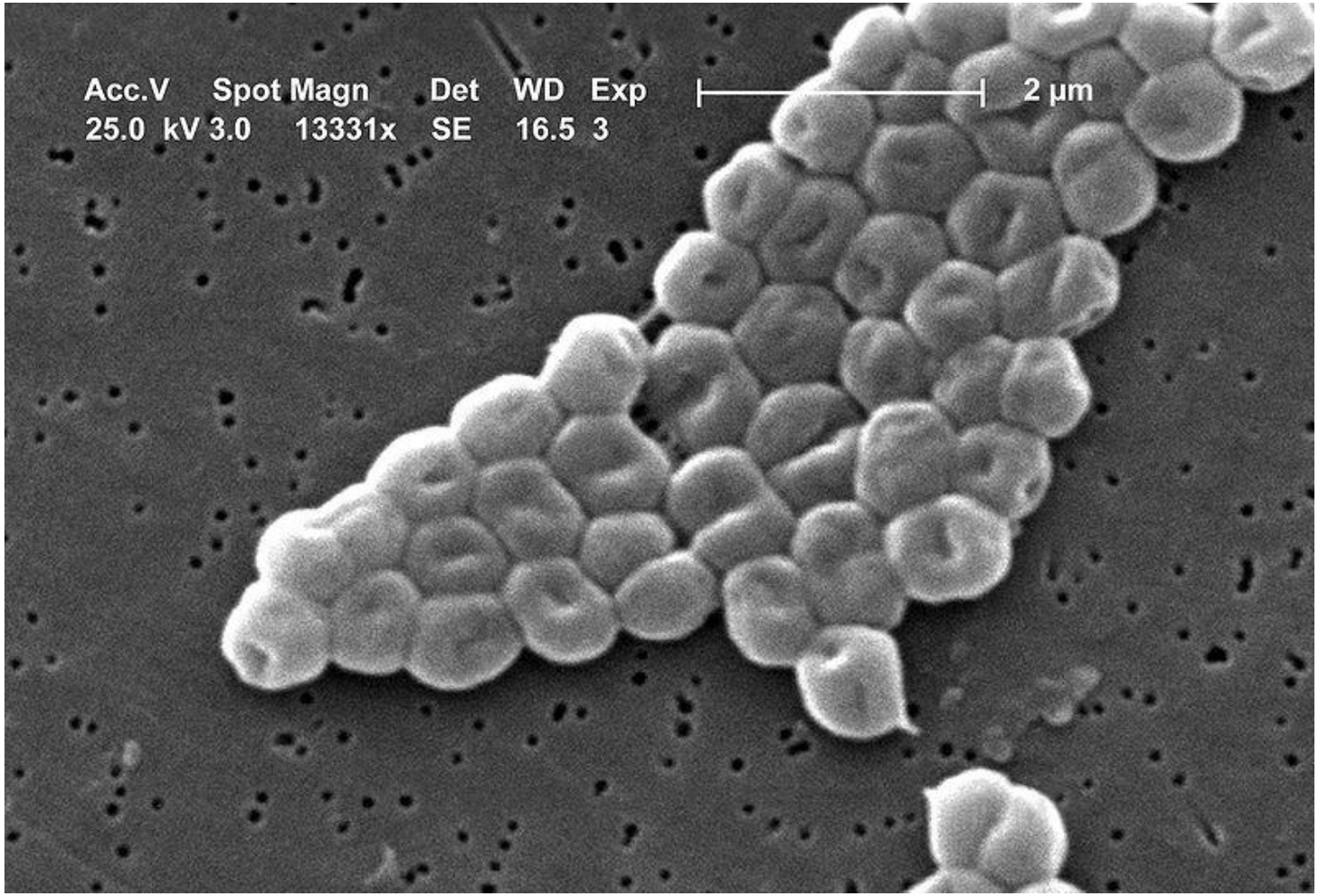
Mô hình lây truyền NKBV



3.5. Những tác nhân

- **Các vi khuẩn 90%**
- **Các virut 8%**
- **Nấm ~1%**
- ***Một số vi khuẩn gây NTBV chính:***
  - **Acinetobacter baumannii**
  - **Trực khuẩn mủ xanh (Pseudomonacaes)**
  - **Tụ cầu vàng Staphylococcus aureus**
  - **Phế cầu (Pneumonie aeruginosa)**
  - **Trực khuẩn đường ruột (Enterococcus spp)**

Acinetobacter Baumannii



3.6. Bốn loại nhiễm trùng bệnh viện chính:

- **Nhiễm trùng phổi: khoảng 45% NTBV**
- **Nhiễm trùng vết mổ: khoảng 30% NTBV**
- **Nhiễm trùng tiết niệu: khoảng 14% NTBV**
- **Nhiễm trùng huyết: khoảng 11% NTBV**

Hệ thống (cấp độ) phòng ngừa và kiểm soát nhiễm khuẩn

Có 2 cấp độ:

- Phòng ngừa chuẩn: Với mọi bệnh nhân
- Phòng ngừa bổ sung (dựa vào đường lây): Với những BN nghi ngờ/mắc nhiễm khuẩn
  - Lây truyền qua tiếp xúc
  - Lây truyền qua Giọt bắn
  - Lây truyền qua Không khí

⇒PNC là biện pháp căn bản giúp phòng ngừa NK

⇒PNCL là biện pháp quan trọng giúp kiểm soát lây truyền NK

www.yhdp.edu.vn

NỘI DUNG CHÍNH VỀ THỰC HÀNH TỐT KSNK

1. Vệ sinh bàn tay
2. Vô khuẩn
3. Khử khuẩn, tiệt khuẩn dụng cụ y tế
4. Phòng ngừa cách ly
5. VS môi trường và QLCT
6. VS người bệnh
7. Vệ sinh ATTP
8. Xử lý đồ vải
9. Vệ sinh NB tử vong
10. Giám sát NKBV và sử dụng KS

Những biện pháp phòng chống

1. Dự phòng chuẩn cho mọi BN

- <u>Chỉ định</u>
  - Không biết TTNK của BN tại thời điểm nhập viện
  - Giảm nguy cơ NK từ những BN biết và không biết là nguồn nhiễm khuẩn
  - Được thực hiện trong tất cả các CSYT

- **<u>Các biện pháp dự phòng chuẩn:</u>**
  - Vệ sinh bàn tay
  - Sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân
  - Bảo đảm thu gom chất thải thích hợp
  - Lau, loại bỏ ngay dịch/máu bị tràn
  - Các dụng cụ chăm sóc BN được loại bỏ, khử khuẩn hoặc tiệt khuẩn giữa mỗi BN

Dự phòng tiếp xúc

- **Chỉ định**
  - Có tiếp xúc với các bệnh dễ lây: tiêu chảy, nhiễm khuẩn tiêu hoá, tổn thương da
- **Các biện pháp dự phòng tiếp xúc**
  - Buồng riêng cho mỗi bệnh nhân
  - Đi găng khi vào phòng, mặc áo choàng khi tiếp xúc với BN, bề mặt, vật liệu bị NK
  - Rửa tay trước và sau khi tiếp xúc với bệnh nhân, và khi rời buồng bệnh.
  - Hạn chế bệnh nhân ra ngoài buồng bệnh
  - Làm sạch, khử khuẩn và tiệt khuẩn dụng cụ và môi trường thích hợp

Dự phòng qua các giọt bắn

- **Chỉ định**
  - Đối với các giọt nhỏ (>5 µm) phòng các bệnh như viêm màng não, bạch hầu...

- **Các biện pháp dự phòng**
  - Bố trí buồng riêng cho mỗi bệnh nhân
  - Khẩu trang cho nhân viên y tế
  - Hạn chế di chuyển BN, đeo khẩu trang ngoại khoa cho BN khi rời buồng bệnh

Dự phòng đường không khí

- **Chỉ định:**
  - Đối với các mầm bệnh có kích thước <5micromet phòng các bệnh như lao, sởi, thuỷ đậu
- **Các biện pháp dự phòng:**
  - Bố trí buồng riêng có thông khí thích hợp
  - Sử dụng khẩu trang có độ lọc cao
  - Bệnh nhân luôn ở trong buồng bệnh